

第11回 電子処方箋等検討ワーキンググループ資料

厚生労働省 政策統括官付

医療情報連携担当参事官室

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

報告事項

- ・医療情報化支援基金（ICT基金）
令和8年10月以降の電子処方箋の導入補助

医療情報化支援基金（ICT基金） 令和8年10月以降の電子処方箋の導入補助

- 医療機関に対する電子処方箋管理サービスの導入に係る費用への補助について、**補助対象とする導入期限を令和9年3月まで延長し、施設への補助を引き続き実施する。**薬局については、補助対象とする導入期限を令和8年9月までで終了する。
- ただし、現在、厚生労働省において、**電子カルテ、電子処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスの一体的導入の普及促進を進める観点から、令和9年度に①厚生労働省において認証されたクラウドネイティブ型電子カルテ製品（※）の導入支援、②政府の医療DXサービスへの接続機能を有する「パッケージ版電子カルテ製品」（※）の導入支援（電子カルテ更改時）を検討**しており、本補助金の利用の検討の際には、こうした点や政府の医療DXサービスへの接続機能の有無も考慮の上、各医療機関の電子カルテの導入・更新の計画をご検討いただくよう周知する。
(※) ①・②の製品ともに電子処方箋管理サービスへの接続機能を有することを要件とする予定。
- 令和9年4月以降の取扱いについては、電子カルテの普及計画等を踏まえた電子カルテと電子処方箋の一体的な導入に係る補助の内容を改めて検討する。

令和8年9月までに導入	大規模病院	病院	診療所	大型チェーン薬局	薬局
院外処方機能 (基本機能+追加機能)	200.7万円を上限に補助 ※事業額の602.2万円を 上限に、その1/3を補助	135.3万円を上限に補助 ※事業額の405.9万円を 上限に、その1/3を補助	27.1万円を上限に補助 ※事業額の54.2万円を 上限に、その1/2を補助	13.8万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円を 上限に、その1/4を補助	27.7万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円を 上限に、その1/2を補助
院外処方機能+院内処方機能 (基本機能+追加機能+院内処方機能)	247.7万円を上限に補助 ※事業額の743.2万円を 上限に、その1/3を補助	169.6万円を上限に補助 ※事業額の508.8万円を 上限に、その1/3を補助	35.9万円を上限に補助 ※事業額の71.7万円を 上限に、その1/2を補助	15.1万円を上限に補助 ※事業額の60.3万円を 上限に、その1/4を補助	30.2万円を上限に補助 ※事業額の60.3万円を 上限に、その1/2を補助
令和8年10月以降導入	大規模病院	病院	診療所	大型チェーン薬局	薬局
院外処方機能 (基本機能+追加機能)	200.7万円を上限に補助 ※事業額の602.2万円を 上限に、その1/3を補助	135.3万円を上限に補助 ※事業額の405.9万円を 上限に、その1/3を補助	27.1万円を上限に補助 ※事業額の54.2万円を 上限に、その1/2を補助	なし	なし
院外処方機能+院内処方機能 (基本機能+追加機能+院内処方機能)	247.7万円を上限に補助 ※事業額の743.2万円を 上限に、その1/3を補助	169.6万円を上限に補助 ※事業額の508.8万円を 上限に、その1/3を補助	35.9万円を上限に補助 ※事業額の71.7万円を 上限に、その1/2を補助	なし	なし

【大規模病院】病床数が200床以上の病院 【大型チェーン薬局】グループで処方箋の受付が月4万回以上の薬局
【追加機能】リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋D検索

(参考)【概要】電子カルテ普及計画

ー クラウドネイティブ型電子カルテの普及／全国的な医療情報の連携／サイバーセキュリティ対策の強化 ー

- 電子カルテは、医療機関の基幹業務システムであるのみならず、①患者に質の高い医療を提供するための情報連携基盤であり、同時に、②創薬や医療機器開発を含む、様々なライフサイエンスの基礎データを創出する情報基盤としての役割を持つ。
- サイバーセキュリティ対策を含む、「必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテ」の普及に向けた取組は、国民に、質の高い医療を、効率的かつ安全に提供することを目指すもの。

目標

2028年度までに、電子カルテ未導入の200床以上の病院(療養病床等が中心の病院を除く。)について電子カルテ普及率100%を目指す。
2030年までに、①電子カルテ普及率約100%、②地域の拠点病院のサイバーセキュリティ対策100%、③大病院向けクラウドネイティブ型製品の提供 を目指す。

方針

医療機関のシステムのクラウドネイティブ化を集中的に実施。

未導入：クラウドネイティブ型電子カルテの導入推進。

導入済：更新のタイミングで、①クラウドネイティブ型電子カルテ、②政府医療DXサービスに対応し、ノンカスタマイズであること等を要件とするパッケージ版・電子カルテ製品に移行支援。その間、オンプレ型も対象に、地域の主要な病院からサイバーセキュリティ対策強化。

施策

2027年度～

主に中小病院・医科診療所向けの主な対策

認証されたクラウドネイティブ型電子カルテ製品の普及支援

- ▶ 標準仕様に即したクラウドネイティブ型電子カルテの認証制度の構築
- ▶ 認証された電子カルテ製品の導入支援

＜クラウドネイティブ型が普及するまでの経過的な対応＞

「パッケージ版・電子カルテ製品」の普及支援

- ▶ 政府の医療DXサービスに対応し、セキュリティ対策を備え、ノン・カスタマイズでの導入を前提とする「パッケージ版・電子カルテ」の普及支援

「導入版」の普及支援 (医科診療所向け。紙カルテ併用・医療情報の共有)

電子カルテ情報共有サービス等への接続支援

主に大病院(機能が高い病院)向けの主な対策

大病院向けクラウドネイティブ型製品(電子カルテ・部門システム)の開発支援

- ▶ 大病院向けクラウドネイティブ型システムの開発支援
- ▶ 電子カルテ・部門システムの標準インターフェイスの構築

＜クラウドネイティブ型が普及するまでの経過的な対応＞

「パッケージ版・電子カルテ製品」の普及支援

- ▶ 政府の医療DXサービスに対応し、セキュリティ対策を備え、ノン・カスタマイズでの導入を前提とする「パッケージ版・電子カルテ」の普及支援

電子カルテ情報共有サービス等への接続支援

報告事項

- OTC類似薬の一部保険外療養への対応について

一部保険外療養の創設

趣旨・概要

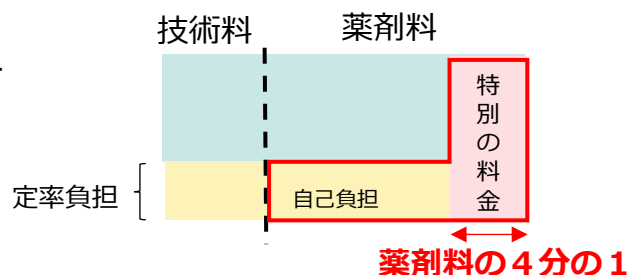
- ①医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保
②現役世代を中心とする保険料負担上昇の抑制の観点から行うもの。
- OTC医薬品（要指導医薬品又は一般用医薬品）との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの（「一部保険外療養」という。）を創設。（令和9年3月施行を想定）

○ 特別の料金の対象となる医薬品の範囲・特別の料金の設定

対象医薬品の範囲：77成分（1,042品目）

主な対応症状は、鼻炎、胃痛・胸やけ、便秘、解熱・痛み止め、風邪症状全般、腰痛・肩こり、みずむし、口内炎、皮膚のかゆみ・乾燥肌 等。

特別の料金：対象薬剤の薬剤費の1/4



○ 配慮が必要な者

こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方等に対する配慮を検討。

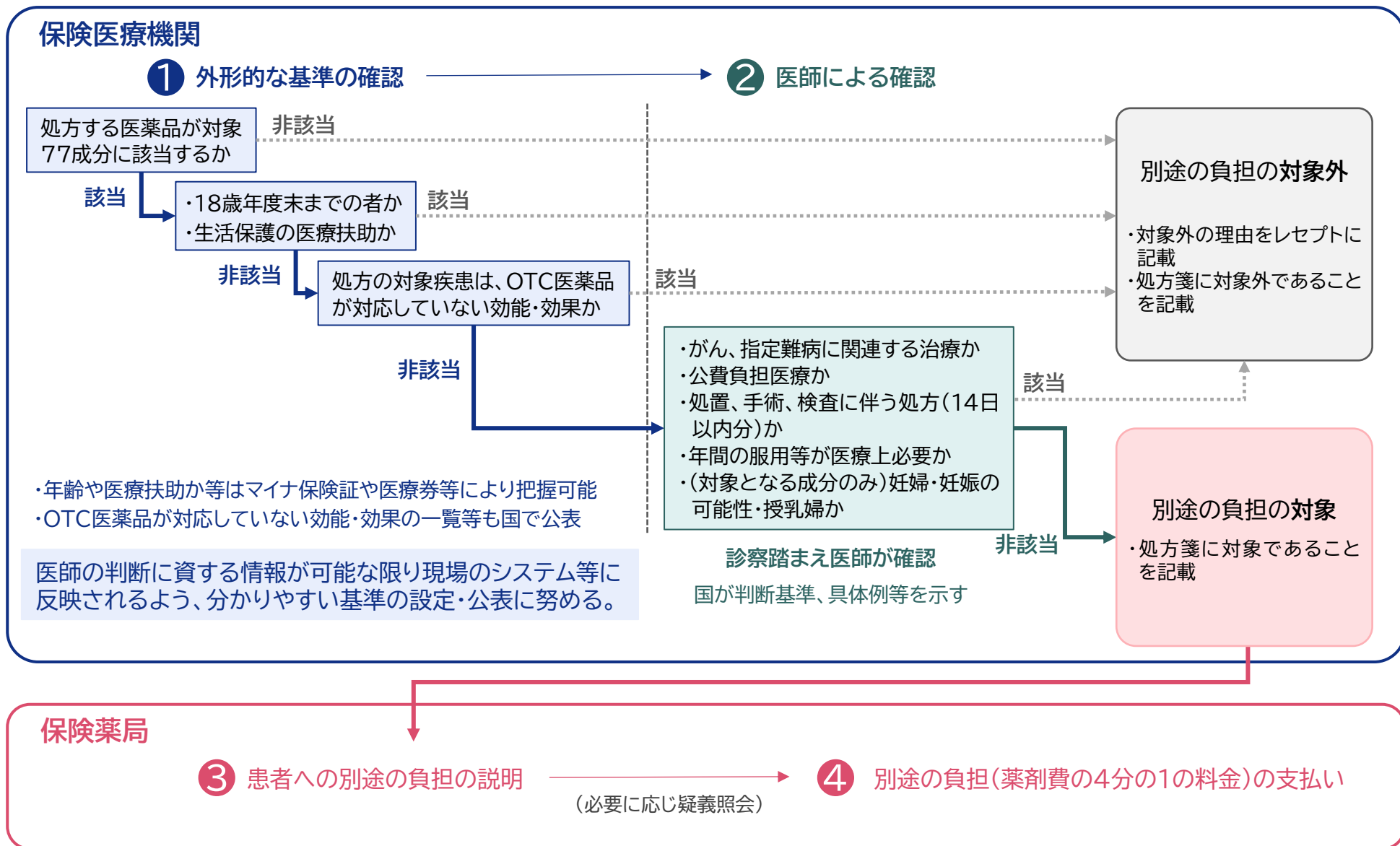
※上記の事項については、告示事項。

※選定療養に係る「特別の料金」には別途消費税がかかっている。

※上記の事項に係る厚生労働大臣の定めのある在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討規定を法附則で規定。

※品目は令和8年8月1日時点

OTC類似薬の一部保険外療養の実務フロー（院外処方の場合）



※ 制度が複雑化しないよう、OTC類似薬の一部保険外療養に該当する場合は、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めないこととする。

処方箋様式の見直しについて

処方箋様式を改正し、「一部保険外療養」欄を追加する。令和9年3月以降に対象医薬品を処方する場合は、別途の負担の対象である場合は「○」を、別途の負担の対象外である場合は「－」を処方箋に記載することとする。

処方箋
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)

公費負担者番号		保険者番号	
公費負担医療の受給者番号		被保険者資格に係る記号・番号 (扶養)	
氏名	保険医療機関の所在地及び名称		
生年月日	年 月 日	男・女	電話番号
区分	被保険者	被扶養者	保険医氏名
交付年月日	令和 年 月 日	処方箋の 使用期限	令和 年 月 日
変更不可 (医療上必要)	患者希望	個々の処方箋について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更が差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。 一部保険外療養の対象医薬品を処方した場合には、「一部保険外療養」の欄に、特別の料金の対象である場合は「○」を、特別の料金の対象外である場合は「－」を記載すること。	
処方欄		リフィル可 ☐ (回) ※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋	
保険医署名		「した場合は、署名又は記名・押印すること。」 保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。) □1回目調剤日(年 月 日) □2回目調剤日(年 月 日) □3回目調剤日(年 月 日) □1回目調剤予定日(年 月 日) □2回目調剤予定日(年 月 日) □3回目調剤予定日(年 月 日)	
調剤済年月日		公費負担者番号	
保険薬局の所在地 及び名称 保険医氏名		公費負担医療の 受給者番号	

備考 1. 「処方」欄には、薬名、用量、用法及び用法を記載すること。
2. この用紙は、A列3部を標準とする。
3. 薬名は、処方箋記載の品名(商品名)と一致する品名(商品名)を記載すること。第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医師」と読み替えるものとする。

変更不可 (医療上必要)	患者希望	一部保険外 療養	処方欄
			リフィル可 ☐ (回) ※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋

処方箋記載のイメージ

・対象のOTC類似薬を処方する場合

変更不可 (医療上必要)	患者希望	一部保険外 療養	処方欄
		○	品目名
		－	品目名

← OTC類似薬の一部保険外療養の**別途の負担の対象**

← OTC類似薬の一部保険外療養の**別途の負担の対象外**

・長期収載品でありOTC類似薬でもある場合

		○	品目名
	×	－	品目名
×		－	品目名

← OTC類似薬の一部保険外療養の**別途の負担の対象**
(長期収載品の選定療養は対象外)

← 長期収載品の選定療養の特別の料金の対象 (患者希望)

← 長期収載品の選定療養の特別の料金の対象外 (医療上必要)

※処方箋様式は当面の間、変更前の様式を使用することを可能とする経過措置を設ける。

電子処方箋管理サービスに係る変更点

- 電子処方箋発行時に出力される処方内容（控え）において、O T C類似薬の一部保険外療養に係る判定結果が把握できるよう、「類似薬」や「類似薬 外」と表示できるように対応する。
- 上記については、医師がO T C類似薬に該当するかを判断し、電子カルテに入力することが想定される。なお、電子カルテの機能によっては、当該条件を自動判定し、電子処方箋管理サービスへ登録が可能となる部分もあると考えられる。

<処方内容（控え）出力例>

処方内容（控え）
こちらは処方箋原本ではありません。

ページ： 1 / 1

引換番号： 1 2 3 4 5 6
マイナンバーカードをお持ちでない方は上記の引換番号を薬局にお伝えください

氏 名	発行年月日	使用期限
特ニ 太郎 基金 太郎 様	2027年 3月 1日	2027年 3月 4日

※記載無しは発行年月日含めて4日間有効

【処方内容】			
	RP001	テスト薬アイウ錠10mg錠	3錠 28日分
類似薬	RP002	テスト薬ABC錠20mg錠	3錠 28日分
類似薬 外	RP003	テスト薬サシスセソタチソテフ錠20mg錠	1錠 28日分
患者希望	RP004		3錠
			3錠
			3錠 各14日分
医療上必要	RP005		3錠 28日分
	RP006		3錠 28日分

以下余白

<類似薬 / 類似薬外 の記載例>

ケース	処方内容（控え）上の記載
O T C類似薬の一部保険外療養の <u>別途の負担の対象</u>	類似薬
O T C類似薬の一部保険外療養の <u>別途の負担の対象外</u>	類似薬 外
O T C類似薬でない処方薬	空白 ※

※「患者希望」等の別の項目に該当する場合はその内容を記載

電子処方箋管理サービスに係る変更点

- 処方箋と同様に処方内容（控え）において、OTC類似薬（特別料金・対象外）が把握できるよう、電子処方箋管理サービス記録条件仕様（処方編・院内処方編）において、「薬品補足区分」に「**9：特別料金（OTC類似薬）**」「**10：特別料金対象外（OTC類似薬）**」を新規区分として表示されるよう改修を行う。
- 上記についても、処方内容（控え）同様、医師による電子カルテ上の入力及び、電子カルテによる自動判定により電子処方箋管理サービスへの登録が可能となる部分もあると考えられる。

<電子処方箋管理サービスにおける薬品補足区分の変更>

記録条件仕様（処方編） 別表16（薬品補足区分）

記録条件仕様（院内処方編） 別表10（薬品補足区分）

コード名	コード	内容
薬品補足区分	1	一包化
	2	粉砕
	3	後発品変更不可
	4	剤形変更不可
	5	含量規格変更不可
	6	剤形変更不可及び含量規格変更不可
	7	JAMI補足用法（不均等を除く）
	8	先発医薬品患者希望
	9	特別料金（OTC類似薬）
	10	特別料金対象外（OTC類似薬）
	11～99	未使用

<電子処方箋管理サービスへの情報連携例（OTC類似薬関連）>

電子カルテ上の入力	電子処方箋管理サービスへの登録内容
特別料金（OTC類似薬）	9：特別料金（OTC類似薬）として連携
特別料金対象外（OTC類似薬）	10：特別料金対象外（OTC類似薬）として連携
後発薬への変更不可指定 ＋ 特別料金（OTC類似薬）	3：後発品変更不可 ＋ 9：特別料金（OTC類似薬）として連携
患者希望による先発薬指定 ＋ 特別料金（OTC類似薬）	8：先発医薬品患者希望 ＋ 9：特別料金（OTC類似薬）として連携

- 長期収載品同様、同一の医薬品であっても対象患者により処方箋、処方内容（控え）の出力内容が異なる。
- 特に条件が重複した際、どのような出力内容が求められるかは解釈を一致させる必要がある。
- 以下に、処方箋の出力例をもとにした、処方内容（控え）への出力内容及び、電子処方箋管理サービスへの登録情報の対応表を示した。

処 方 箋												
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)												
公費負担者番号							保険者番号					
公費負担医療 の受給者番号							被保険者資格に係る 記号・番号	(枝番)				

処方内容（控え）

こちらは処方箋原本ではありません。

引換番号：123456

マイナンバーカードをお持ちでない方は上の引換番号を薬局にお伝えください。

ページ：1 / 1



氏 名	発行年月日	使用期限
姓 名 姓 名	2027年 3月 1日	2027年 3月 4日

電子処方箋
管理サービス

11